| | | |
|---|---|---|
| UNIVERSITÉ PRIVÉE DE MARRAKECH<br>UNIVERSITÉ<br>**RECONNUE PAR L'ÉTAT**<br>جامعة معترف بها من طرف الدولة | **Année universitaire : 2022-2023**<br>**Niveau : MED 4**<br>**Examens Session Normale (Mai 2023)** | FPMM<br>FACULTÉ PRIVÉE DE MÉDECINE DE MARRAKECH<br>UNIVERSITÉ PRIVÉE DE MARRAKECH |
| **Semestre : S8** | **Module : Appareil locomoteur**<br>**Durée :1 heure**<br>**Coordonnateur : Pr. R. Niamane** | |

**TRAUMATO-ORTHOPEDIE : 1 à 20 – RHUMATOLOGIE : 21 à 40 - MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION : 41 à 50.**

**1 - Toutes les propositions suivantes répondent aux principes du traitement des fractures de l'extrémité inferieure du fémur sauf deux lesquelles ?**

A. C'est une urgence thérapeutique
B. Chercher une contention solide
C. Chercher une mobilisation précoce
D. Chercher une mobilisation tardive
E. Chercher une contention souple

**2 - La triade diagnostique d'une tendinopathie comporte :**

A. Douleur à la palpation du tendon
B. Douleur musculaire
C. Douleur à l'étirement du tendon
D. Douleur à la contraction résistée
E. Aucune réponse juste

**3- La fracture de Hoffa :**

A. Est une fracture du radius distal
B. Est une fracture uni-condylienne du fémur distal
C. Est une fracture à trait frontal
D. Est une fracture de la palette humérale
E. Passe souvent inaperçue sur une radiographie du genou de face

**4- Parmi ces tests lesquels explorent les lésions méniscales :**

A. Le test de Skinner
B. Le scotch test
C. Le grinding test d'Appley
D. Le test de NEER
E. Le test de Brunet Guedj

**5- La technopathie se définit par :**

A. La pathologie du tendon d'Achille
B. La pathologie due à la technique du geste sportif
C. La pathologie rhumatismale du sportif
D. La pathologie endocrinienne du sportif
E. Aucune réponse juste

**6- La présence d'un trait de fracture vertical sur la malléole médiale et sous ligamentaire sur la malléole latérale au cours d'une fracture bimalléolaire présume que le mécanisme est en :**

A. Adduction
B. Abduction
C. Flexion plantaire
D. Flexion dorsale
E. Aucune réponse juste

**7- Les signes de gravité d'une lésion musculaire sont :**

A. La perception d'un craquement
B. L'impotence fonctionnelle totale objective et immédiate
C. L'installation rapide de l'œdème
D. La reprise rapide du sport
E. Aucune réponse juste

**8 - Devant une luxation du genou il faut rechercher impérativement :**

A. Une lésion du nerf crural
B. Une fracture de Hoffa
C. Une lésion de l'artère poplitée
D. Une rupture du tendon calcanéen
E. Aucune réponse n'est juste

**9. Cochez-la ou les réponses exactes concernant les fractures du scaphoïde :**

A. Le cal vicieux est source d'arthrose
B. C'est la fracture la plus fréquente des os du carpe
C. La pseudarthrose est une complication très rare
D. Dans 70 % des cas le siège du trait de fracture est polaire au niveau du col
E. S'accompagne d'une douleur dans la tabatière anatomique

**10. Cochez-la ou les réponses justes relatives aux syndrome des loges**

A. La forme chronique est une urgence diagnostique et thérapeutique
B. Le Crush syndrome est une forme clinique engageant la vie du traumatisé
C. L'augmentation de la pression dans la loge musculaire est au cœur de sa physiopathologie
D. La mesure de la pression de la loge musculaire se fait selon la technique de whiteside
E. Engage la responsabilité médico-légale du médecin lors de la confection d'un plâtre circulaire.

**11. Cochez-la ou les réponses justes relatives aux luxations retro lunaire du carpe**

A. Se définissent par une perte de contact totale entre le lunatum et le radius qui se déplace en arrière
B. Ne s'associe jamais à une fracture du scaphoïde
C. Souvent non diagnostiquée en urgence a la 1ère consultation
D. Le patient se présente avec un tableau très peu douloureux
E. Les lignes de GILULA ne sont plus parallèles sur une radiographie du poignet de face

**12. Lors d'une fracture diaphysaire de l'humérus. Quelle est la complication qui est fréquemment associée à cette fracture.**

A. L'élongation du nerf circonflexe
B. L'atteinte du nerf cubital
C. La paralysie du nerf radial
D. Une plaie de l'artère humérale
E. La pseudarthrose

**13. Cochez-la ou les réponses exactes concernant les traumatismes du poignet :**

A. L'examen clinique doit rechercher les repères du poignet que sont les styloïdes ulnaire et radiale
B. La fracture du triquetrum est plus fréquente que la fracture du scaphoïde
C. La luxation ante lunaire du carpe est plus fréquente que la luxation retro lunaire du carpe
D. Lors de la fracture de Pouteau Colles déplacée la ligne bi styloïdienne devient horizontale
E. L'ostéoporose est un terrain favorisant des fractures de l'extrémité inferieure du radius.

**14. Quelles sont les propositions justes concernant les fractures de l'extrémité inferieure de l'humérus ?**

A. La fracture supra condylienne est une fracture articulaire
B. La fracture sus et inter condylienne est une fracture extra articulaire
C. Les repères cliniques du coude sont conservés
D. La méthode de Blount est un traitement orthopédique chez l'enfant
E. Exposent aux troubles de croissance dans la forme clinique de l'enfant

**15. Un jeune patient est admis au service des urgences pour une fracture de la diaphyse fémorale droite et une fracture ouverte de la jambe droite à la suite d'un accident de moto. Le patient présente :**

A. Un polytraumatisme
B. Un genou flottant
C. Une urgence thérapeutique
D. Un pronostic vital peut être mis en jeu
E. Un pronostic fonctionnel du membre peut être mis en jeu.

**16. Les deux principales complications immédiates que risque ce patient sont :**

A. La thrombophlébite
B. Le choc hypovolémique
C. La pseudarthrose
D. Le retard de consolidation
E. L'embolie graisseuse

**17. Pour diagnostiquer une embolie graisseuse il faut rechercher les signes cliniques suivants :**

A. Une amyotrophie du membre
B. Des signes respiratoires comme une dyspnée.
C. Des signes cutanés à type de pétéchies cervicales et thoraciques.
D. Des troubles de la conscience.
E. Une absence des pouls distaux

**18. La fracture ouverte de la jambe est de type 2 selon Cauchoix et Duparc, ce qui signifie :**

A. Une plaie avec des berges contuses.
B. Une plaie avec une grande perte de substance cutanée
C. Elle peut être compliquée d'une nécrose cutanée secondaire.
D. Le risque infectieux est absent
E. L'ostéosynthèse nécessite toujours un fixateur externe

**19. Un patient se présente aux urgences pour un traumatisme de l'épaule droite à la suite d'un accident de sport, avec douleur et impotence fonctionnelle du membre supérieur qui est en abduction et rotation externe. Quel est votre premier diagnostic ?**

A. Une luxation antérieure de l'épaule.
B. Une luxation inferieure de l'épaule.
C. Une paralysie du plexus brachial.
D. Une luxation acromio-claviculaire
E. Une fracture de la scapula

**20. Les signes cliniques en faveur d'une luxation antérieure de l'épaule sont :**

A. Le signe de l'épaulette avec saillie de l'acromion
B. Le coup de hache externe.
C. L'attitude vicieuse en abduction et rotation externe
D. L'aspect en touche de piano
E. Déformation de la main en col de cygne

21. **Au cours d'une crise de goutte :**
A. Il existe parfois des prodromes qui annonce sa survenue
B. L'articulation du gros orteil est la plus fréquemment touchée.
C. On note une augmentation de la CRP et une hyperleucocytose
D. L'uricémie peut être normale au début
E. L'allopurinol est un test diagnostique et thérapeutique.

22. **M. K. Saadia, de 55 ans a une polyarthrite récente, évoluant depuis moins de 3 mois. Elle touche les poignets, les MCP, les IPP, les MTP et les IPD de manière symétrique et bilatérale. Quels sont les éléments qui orientent vers le diagnostic étiologique ?**
A. La topographie de l'atteinte articulaire.
B. Une vitesse de sédimentation accélérée.
C. Les données de l'échographie articulaire.
D. La présence d'éventuelle manifestations extra-articulaire.
E. Le bilan immunologique.

23. **Chez M. K. M. Saadia, le diagnostic le plus probable est :**
A. Une atteinte ab-articulaire.
B. L'arthrose.
C. La goutte.
D. Le rhumatisme psoriasique.
E. La polyarthrite rhumatoïde.

24. **Une névralgie cervico-brachiale commune, qui se termine au niveau du pouce, oriente vers :**
A. Une radiculalgie C5.
B. Une radiculalgie C6.
C. Une pathologie située à l'étage C5-C6.
D. Une pathologie située à l'étage C6-C7.
E. Une hernie discale possible.

25. **Les germes responsables de mono-arthrite infectieuse chronique sont :**
A. Le staphylocoque aureus.
B. La tuberculose.
C. Le pneumocoque.
D. Les bacilles gram négatif.
E. La syphilis.

26. **Une articulation déformée mais indolente (non douloureuse), est observée en cas de :**
A. Gonarthrose.
B. Polyarthrite rhumatoïde.
C. Tabès.
D. Spondyloarthrite.
E. Arthrite septique.

27. **Concernant l'hyperparathyroïdie primitive :**
A. Le diagnostic est fait habituellement à l'occasion de la découverte fortuite d'une hypercalcémie.
B. Les manifestations osseuses sont devenues rares.
C. Elle est liée le plus souvent à un adénome parathyroïdien.
D. Elle peut être due à un carcinome parathyroïdien.
E. Pour la localisation de la tumeur sécrétante, Il faut au moins deux examens d'imagerie concordants.

28. **Une épaule douloureuse et enraidie peut-être en rapport avec :**
A. Une capsulite rétractile.
B. Une arthrose de l'épaule.
C. Des séquelles de traumatisme articulaire.
D. Une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
E. Une rupture des tendons de la coiffe des rotateurs.

29. **Devant une coxite chronique il faut évoquer :**
A. Une tuberculose de la hanche.
B. Une spondylarthrite.
C. Une coxarthrose.
D. Une ostéonécrose de la tête fémorale.
E. Une algodystrophie de la hanche.

30. **Concernant le syndrome du canal carpien :**
A. Il est plus fréquent chez l'homme que chez la femme.
B. Il correspond à la compression du nerf cubital au niveau du poignet.
C. Il est responsable de paresthésies nocturnes au niveau du pouce, l'index et le majeur.
D. Peut être mis en évidence par la manœuvre PHALLEN.
E. Le traitement est systématiquement chirurgical.

31. **L'algodystrophie à la phase chaude se manifeste par :**
A. Une douleur articulaire et péri-articulaire régionale.
B. Des troubles vaso-moteurs.
C. Une allodynie.
D. Des rétractions capsulo-ligamentaires.
E. Des troubles cutanés trophiques.

32. **La manœuvre de Finkelstein est positive dans :**
A. L'épicondylite latérale.
B. L'épicondylite médiale.
C. La ténosynovite de De Quervain.
D. La tendinopathie du moyen fessier.
E. La tendinopathie de la patte d'oie.

33. **Concernant l'ostéomalacie :**
A. La cause habituelle est l'origine carentielle.
B. Une hypocalcémie et une hyperphosphorémie sont habituelle.
C. Un taux de vitamine D3 sérique à 20 ng/ml, définie la carence.
D. Le traitement repose sur une supplémentation en vitamine D.
E. Peut être responsable de fractures pathologiques.

34. **Dans l'ostéoporose post-ménopausique :**
A. Le dépistage est basé sur la pratique de l'ostéodensitométrie.
B. Le dépistage est basé sur la constations d'une déminéralisation osseuse.
C. La complication majeure est la survenue d'une fracture du col du fémur.
D. Le traitement est basé sur la classe des bisphosphonates.
E. La prévention des chutes chez le sujet âgé fait partie de la prise en charge.

35. **La gonarthrose est :**
A. Est plus fréquente par rapport à la coxarthrose.
B. Est souvent secondaire à une déviation de l'axe fémoro-tibial.
C. S'accompagne d'un épanchement articulaire inflammatoire.
D. S'accompagne d'un syndrome inflammatoire biologique.
E. Se manifeste à la radiographie par un pincement de l'interligne articulaire et une condensation de l'os sous chondral.

36. **Une polyarthrite rhumatoïde se manifeste par :**
A. Une atteinte préférentielle des mains.
B. Une atteinte préférentielle du rachis.
C. Une raideur matinale supérieure à 30 min.
D. La présence du gène HLA B27.
E. La présence d'ostéophytes en regard des articulations des doigts.

37. **On pense à une PR débutante devant les éléments suivants :**
A. Une polyarthrite évoluant en moins de 12 semaines
B. Un nombre d'articulations gonflées ≥ 3.
C. Un test de Squeeze positif
D. Une raideur matinale > 4 heures.
E. Une déformation de type pouce en Z

38. **En faveur du diagnostic d'une spondyloarthrite, on cite :**
A. La présence de cervicalgies inflammatoires.
B. Des anticorps anti-peptides cycliques citrullinés positifs.
C. La présence de syndesmophytes.
D. La présence d'ostéophytes
E. Des talalgies inflammatoires.

39. **L'atteinte enthésique de la spondylarthrite se manifeste par :**
A. Des talalgies mécaniques.
B. Une uvéite antérieure.
C. Des talalgies inflammatoires.
D. Des arthrites des grosses articulations.
E. Des orteils ou doigts en saucisse.

40. **L'atteinte articulaire périphérique dans la spondyloarthrite :**
A. Se manifeste uniquement sur les genoux et les hanches
B. Donne le plus souvent une oligo-arthrite.
C. Est fixe additive et symétrique.
D. Se manifeste par des douleurs mécaniques.
E. Touche exclusivement les femmes.

41. **Une patiente de 55 ans souffre de sa hanche droite, vous diagnostiquez, chez elle, une coxarthrose droite modérée avec risque de chute (5 QCM). Les déficiences possibles chez cette patiente sont :**
A. La difficulté à courir
B. La difficulté à faire les courses
C. La difficulté à monter et descendre les escaliers
D. La douleur
E. Le flessum

42. **Les limitations d'activité possibles chez cette patiente :**
A. L'épanchement articulaire
B. La difficulté à aller à la mosquée
C. La difficulté à marcher
D. La difficulté à monter les escaliers
E. La difficulté à pratiquer du sport

43. **Les restrictions de participation possible chez cette patiente :**
A. La difficulté à promener son chien
B. La difficulté à faire ces courses
C. La difficulté à faire la prière
D. Le craquement articulaire
E. La limitation articulaire

44. **Pour complément de prise en charge, vous adresser cette patiente chez :**
A. L'ergothérapeute
B. L'opticien
C. L'orthophoniste
D. L'orthoprothésiste
E. Le kinésithérapeute

**45. Quelle aide technique vous allez lui prescrire :**

A. Un cadre de marche
B. Un déambulateur
C. Une canne à porter à droite
D. Une canne à porter à gauche
E. Un fauteuil roulant

**46. Parmi les propositions suivantes, lesquelles constituent un facteur de risque de lésion musculaire ?**

A. Dopage
B. Erreurs diététiques
C. Froid extrême
D. L'étirement musculaire
E. L'hyperhydratation

**47. Les caractéristiques d'une bonne orthèse :**

A. De série
B. Esthétique
C. Réalisée dans les délais
D. Sophistiquée
E. Sur mesure

**48. Concernant les facteurs de risque de chute de la personne âgée**

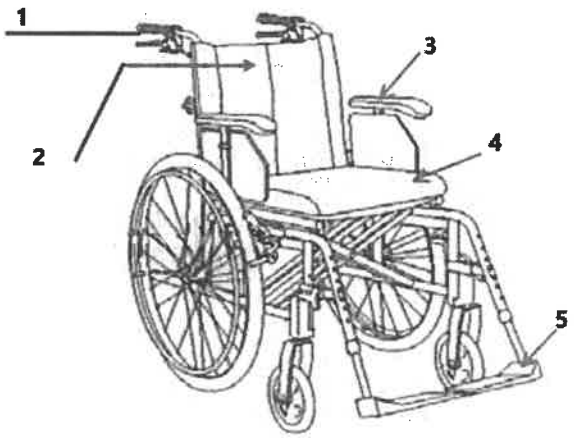
A. La baisse de l'acuité visuelle
B. La sédentarité
C. La surmotivation
D. Le sexe masculin
E. Peuvent être intrinsèques

**49. Concernant la marche normale de l'Homme :**

A. A un certain moment les deux pieds sont décollés en même temps
B. Elle est acquise à partir de 18 mois de vie
C. Elle est automatique
D. Elle est reflexe
E. Elle volontaire

**50. Cochez-la ou les bonne (s) réponse (s) selon la légende du schéma d'un fauteuil roulant :**

A. Le chiffre 1 représente les freins
B. Le chiffre 2 représente l'assise
C. Le chiffre 3 représente la main courante
D. Le chiffre 4 représente le dossier
E. Le chiffre 5 représente le repose pied



Code candidat

Nom

Prénom

CORRECTION

Remarques :

Université Privée de Marrakech
Faculté Privée de Médecine de Marrakech
Année Universitaire : 2022-2023

MED4E19 Rhumatologie 2022-2023
MED4E17 Traumato-Orthopédie 2022-2023
MED4E18 Réadaptation fonctionnelle 2022-2023

Maladies de l'appareil locomoteur
NIAMANE Radouane

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| Q2 | ☒ | ☐ | ☒ | ☒ | ☐ |
| Q3 | ☐ | ☒ | ☒ | ☐ | ☒ |
| Q4 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
| Q5 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Q6 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Q7 | ☒ | ☒ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Q8 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Q9 | ☒ | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ |
| Q10 | ☐ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
| Q11 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
| Q12 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Q13 | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| Q14 | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ | ☒ |
| Q15 | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
| Q16 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ |
| Q17 | ☐ | ☒ | ☒ | ☒ | ☐ |
| Q18 | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Q19 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Q20 | ☒ | ☒ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Q21 | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☐ |
| Q22 | ☒ | ☐ | ☒ | ☒ | ☒ |
| Q23 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| Q24 | ☐ | ☒ | ☒ | ☐ | ☒ |
| Q25 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ |

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Q26 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Q27 | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
| Q28 | ☒ | ☒ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Q29 | ☒ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Q30 | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ | ☐ |
| Q31 | ☒ | ☒ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Q32 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Q33 | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| Q34 | ☒ | ☐ | ☒ | ☒ | ☒ |
| Q35 | ☒ | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ |
| Q36 | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Q37 | ☒ | ☒ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Q38 | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
| Q39 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
| Q40 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Q41 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| Q42 | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ | ☐ |
| Q43 | ☒ | ☒ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Q44 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |
| Q45 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| Q46 | ☒ | ☒ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Q47 | ☐ | ☒ | ☒ | ☐ | ☒ |
| Q48 | ☒ | ☒ | ☒ | ☐ | ☒ |
| Q49 | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ | ☒ |
| Q50 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |